



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN
KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN
PASIHEN RS PRIMA HUSADA MALANG
BULAN APRIL TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bulan April Tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat dilaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dilakukan berdasarkan tersedianya data, penggunaan data secara efektif dapat dilakukan secara *evidence-based* praktek klinik dan *evidence-based management*, berhubung sebagian besar rumah sakit mempunyai sumber daya terbatas, maka rumah sakit tidak dapat mengumpulkan data untuk semua hal yang diinginkan. Jadi rumah sakit memilih proses dan hasil *outcome* praktik klinik dan manajemen yang harus dinilai atau diukur dengan mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan jenis pelayanan. Penilaian sering terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar atau cenderung menimbulkan masalah. Pimpinan rumah sakit memiliki peranan kunci untuk memastikan rencana mutu dan keselamatan pasien membentuk budaya organisasi rumah sakit dan memberi dampak pada setiap aspek kegiatan berupa Standar Pelayanan Minimal dan pencapaiannya sesuai indikator yang dipergunakan di setiap unit pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada.

Dengan tersusunnya Laporan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bulan April tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Rumah Sakit Prima Husada adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Rumah Sakit Prima Husada tersebut, maka didukung oleh 3 misi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, akurat. 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas prima yang mengedepankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan (STARKES). Kegiatan ini dilakukan di setiap unit terkait untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada pada tahun 2025 menetapkan indikator rumah sakit yang sesuai dengan STARKES. Berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikan indikator rumah sakit sebagai berikut: indikator mutu nasioanal (INM), Indikator mutu sasaran keselamatan pasien, Indikator mutu prioritas klinis rumah sakit, Indikator mutu tujuan strategis, indikator mutu perbaikan sistem, Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit).

B. Tujuan

Tujuan Umum

Mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada.

Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada melalui pemantauan indikator mutu yang telah ditetapkan pada rapat kerja akhir tahun.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu spesifik lain yang dilakukan oleh tim/ komite/ unit terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas mengenai program mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada

BAB II

KEGIATAN PEMANTAUAN INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT TAHUN 2026

A. Kegiatan Pokok

Kegiatan pemantauan indikator mutu pada bulan April tahun 2026 yang dilaporkan pada Bulan Mei Tahun 2026.

B. Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/unit
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

C. Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/unit dilakukan setiap bulan, menyusun program perbaikan mutu oleh tim peningkatan mutu rumah sakit dilaporkan pada saat rapat bulanan.
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap tiga bulan.
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu

D. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh petugas pengumpul data unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab pengumpul data. Hasil analisis tersebut kemudian dilaporkan ke kepala instalasi/unit, hasil ditulis pada Form Supervisi dilengkapi laporan tindak lanjut program untuk indikator yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan atau setiap ditemukan suatu permasalahan di setiap instalasi kerja dan ditembuskan Sub Komite Peningkatan Mutu.

BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan capaian indikator mutu nasional RS Prima Husada Malang pada bulan April tahun 2026.

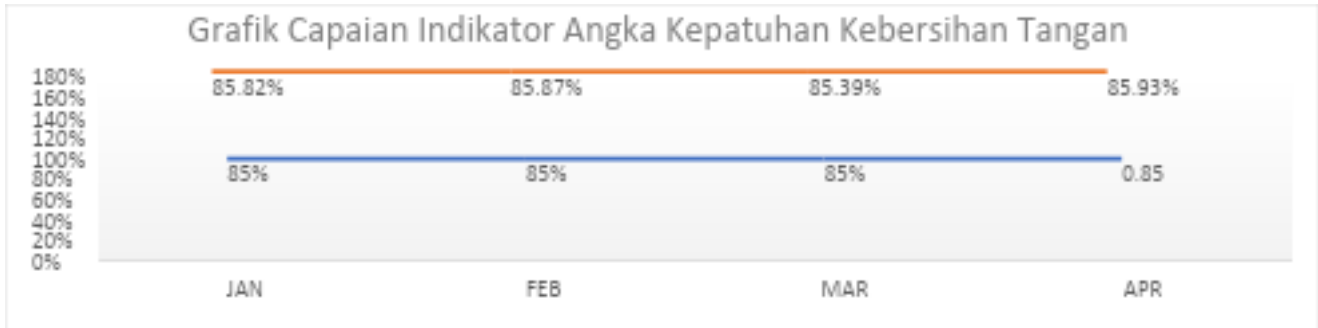
Tabel 3.1 Capaian Indikator Mutu Nasional RS Prima Husada Malang bulan April tahun 2026

NO	Judul Indikator	Bulan												Stan- dar	Rata- Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	85.82%	85.87%	85.39%	85.93%									≥ 85%	85.75%	Ditingkatkan
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96.82%	96.88%	96.40%	96.48%									100%	96.65%	PDSA
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	99.96%	99.06%	99.89%	99.97%									100%	99.72%	PDSA
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%									≥ 80%	100.00%	Dipertahankan
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	89.90%	86.30%	89.20%	95.04%									≥ 80%	90.11%	Dipertahankan

6.	Penundaan Operasi Elektif	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									≤ 5%	0.00%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	66.75%	73.63%	68.35%	87.98%									≥ 80%	74.18%	Ditingkatkan
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%									100%	100.00%	Dipertahankan
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	86.13%	86.07%	86.45%	86.33%									≥ 80%	86.25%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	30.51%	16.11%	18.75%	53.33%									≥ 80%	29.68%	PDSA
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	91.54%	93.31%	95.60%	96.55%									100%	94.25%	PDSA
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%									≥ 80%	100.00%	Dipertahankan
13.	Kepuasan Pasien	99.70%	99.89%	99.79%	99.88%									≥ 76,61	99.57%	Dipertahankan

3.1.1 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

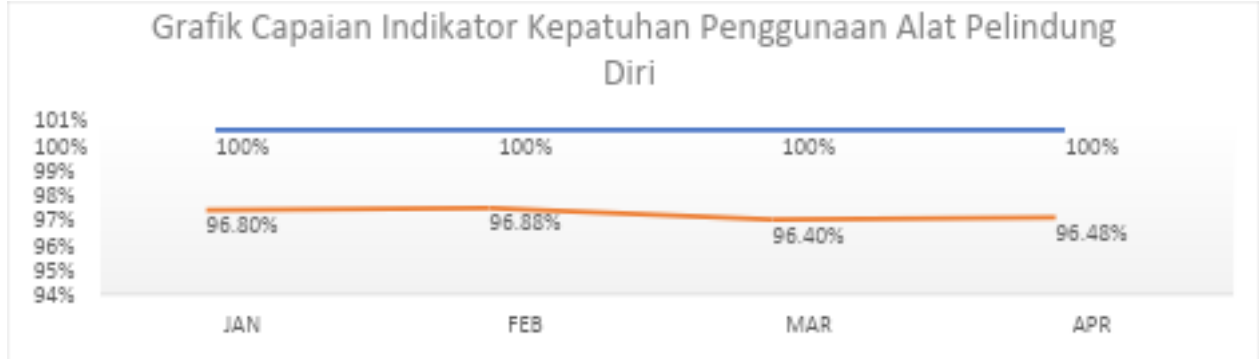


Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan RS Prima Husada Malang bulan April tahun 2026

Analisis:

Pada Bulan April, angka kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Malang mencapai 85.93%. Berdasarkan grafik pada gambar 3.1, diketahui bahwa capaian ini mengalami peningkatan dari Bulan Maret sebesar 0.54%. Capaian ini telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemenkes yakni $\geq 85\%$. Meskipun capaian di bulan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan, namun masih dekat dengan batas tersebut sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaiannya. Unit yang memiliki capaian kepatuhan kebersihan tangan tertinggi adalah IKO dengan capaian sebesar 94.80%. Sementara unit dengan capaian kebersihan tangan terendah adalah Instalasi Gizi dengan capaian sebesar 81.94%. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat program edukasi, monitoring kepatuhan secara berkala, dan pemberian umpan balik kepada petugas. Sebuah studi Quality Improvement yang dilakukan oleh Sitohang dkk., (2025) membuktikan bahwa edukasi tenaga kesehatan, monitoring dan supervisi IPCN, serta simulasi langsung 5 *Moments Hand Hygiene* efektif dalam meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan di rumah sakit.

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)



Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) RS Prima Husada Malang bulan April 2026

Analisis:

Pada Bulan April, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di RS Prima Husada Malang mencapai 96.48% yang mengalami penurunan dari Bulan Maret sebesar 0.08%. Capaian ini masih memiliki gap sebesar 3.52% dari standar minimal yang ditetapkan yakni 100%. Unit yang mencapai angka 100% dalam kepatuhan penggunaan APD terdiri dari IGD, HCU, ICU, PICU, IKO, IFRS, Pengadaan Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, IRNA 2A, IRNA 2C, IRNA 3A, IRNA 3C, IRNA 4A, IRNA 6A, IRNA 7A, Maternitas, Neonatologi, dan Perinatologi. Sementara unit yang memiliki angka kepatuhan penggunaan APD terendah berada di CSSD yaitu sebesar 75.56%, mengalami penurunan sebesar 11,66% dari Bulan Maret. Unit yang mengalami penurunan dari bulan sebelumnya selain CSSD, yaitu Instalasi Gizi (penurunan sebesar 0.99%), dan IRNA 5C (penurunan sebesar 0.86%). Unit yang mengalami kenaikan angka kepatuhan penggunaan APD dari bulan sebelumnya yakni CS (kenaikan sebesar 1.80%), IRJA (kenaikan sebesar 1.37%), IRNA 7A (kenaikan sebesar 2.22%), dan IRNA 8A (kenaikan sebesar 0.50%).

Tabel 3.2 PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan April tahun 2026

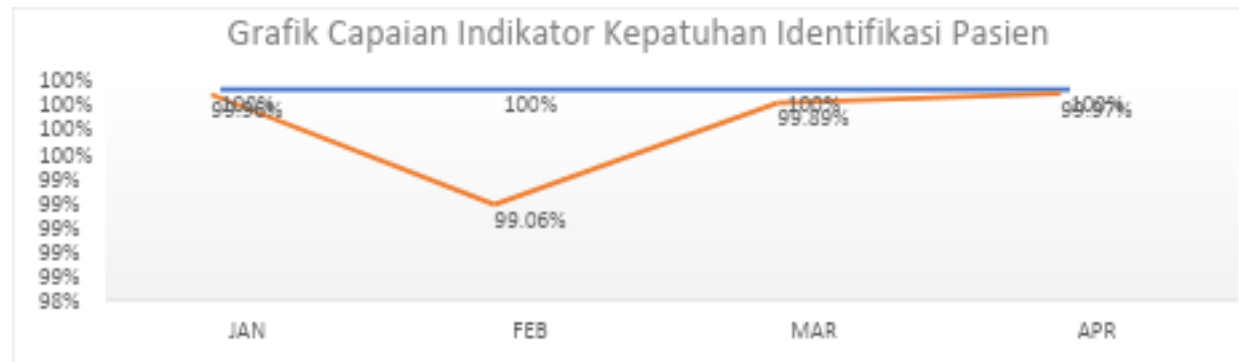
Problem	Capaian kepatuhan penggunaan APD di RS Prima Husada Malang pada Bulan April 2026 sebesar 96.48% yang artinya masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan yakni 100%. Terdapat gap sebesar 3.52% yang dapat berisiko pada keselamatan staf dan pasien. Masalah yang ditemukan adalah masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD baik yang tidak lengkap maupun berlebihan, pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata, kebiasaan kerja lama masih memengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten, dan monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata.
Plan	Mengupayakan peningkatan kepatuhan penggunaan APD sehingga mencapai standar minimal (100%) dengan mengingatkan petugas yang memakai APD berlebihan, mengevaluasi penggunaan stok APD, memberikan edukasi, dan melakukan supervisi terkait ketersediaan dan penggunaan APD.
Do	1. Pengawasan penggunaan APD 2. Edukasi penggunaan APD
Study	Capaian target bulan ini masih belum memenuhi standar minimal (100%) sebesar 96.48%. Terjadinya penurunan dari bulan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan perilaku penggunaan APD, menurunnya kesadaran staf, atau kurangnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang

	dilakukan bulan sebelumnya. Beberapa upaya yang dilakukan dari bulan sebelumnya yakni reminder kepada staf untuk memakai APD sesuai standar, peningkatan monitoring oleh kepala unit. Dari upaya tersebut didapatkan kenaikan kepatuhan penggunaan APD sebesar 0.08% dari bulan sebelumnya. Upaya ini bisa terus dilakukan untuk dapat semakin meningkatkan capaian kepatuhan penggunaan APD sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Action	1. Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. 2. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 3. Meningkatkan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 4. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 5. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.

Tabel 3.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan Monitoring Kepatuhan Penggunaan APD	Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	Unit pelayanan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Komite PPI, IPCN • Kepala Ruangan	Berkelanjutan
2	Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	Seluruh staf unit pelayanan	Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	Setiap bulan
3	Kontroling ketersediaan APD	Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	Unit pelayanan	Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	Setiap bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

Analisis:

Pada Bulan April tahun 2026, kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang mencapai 99.97% yang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 0.08%. Capaian ini semakin mendekati standar minimal yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Namun, masih terdapat gap sebesar 0.03% dari standar yang ditetapkan yang berarti masih ada ketidakpatuhan dalam identifikasi pasien. Unit yang belum mencapai standar angka kepatuhan identifikasi pasien yakni IRJA (99.92%) dan IRNA 3C (99.14%).

Tabel 3.4 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada bulan April tahun 2026

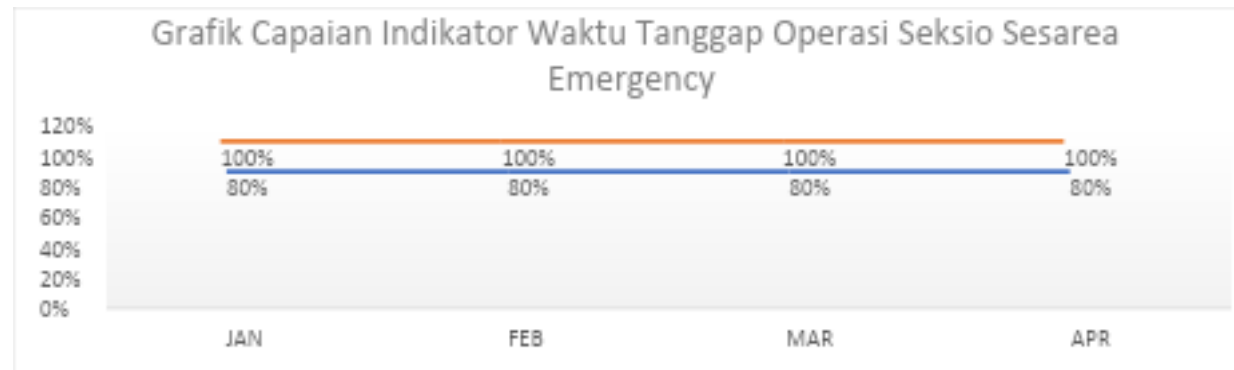
Problem	Capaian kepatuhan identifikasi pasien pada Bulan April sebesar 99.97%. Terdapat gap sebesar 0.03% dari standar yang ditetapkan dikarenakan namun masih ditemukan ketidakpatuhan dalam mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Beberapa petugas hanya mengidentifikasi pasien menggunakan nama saja, yang dapat berisiko terhadap keselamatan pasien.
Plan	Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien di unit pelayanan, ditemukan bahwa kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah. Beberapa temuan antara lain petugas tidak melakukan identifikasi menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir / nomor rekam medis) sebelum tindakan. Selain itu masih terdapat petugas yang tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pasien. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan berupa sosialisasi ulang SPO identifikasi pasien, peningkatan pengawasan oleh kepala unit, serta penguatan budaya keselamatan pasien.
Do	Komite Mutu bersama kepala unit dan ruangan melakukan sosialisasi kembali terkait standar identifikasi pasien kepada seluruh petugas pelayanan. Mengingatkan kembali mengenai pentingnya identifikasi pasien sebelum tindakan. Selain itu dilakukan monitoring dan audit kepatuhan identifikasi pasien secara berkala serta pengawasan langsung oleh kepala unit.

Study	Setelah dilakukan intervensi berupa reminder langsung kepada staf untuk mengidentifikasi pasien sesuai SOP dan pengawasan langsung oleh didapatkan kenaikan sebesar 0.08%. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diartikan bahwa pengingatn kembali kepada staf untuk melakukan identifikasi pasien sesuai SOP dan pengawasan langsung oleh kepala unit mampu meningkatkan angka kepatuhan identifikasi pasien. Masih ada petugas yang belum konsisten melakukan identifikasi sesuai SOP terutama pada kondisi pelayanan yang sibuk atau pada pasien yang sudah dikenal oleh petugas.
Action	Meningkatkan pengawasan oleh kepala unit/ruangan

Tabel 3.5 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan pengawasan oleh kepala unit/ruangan	Meningkatkan kewaspadaaan petugas untuk melakukan identifikasi pasien sesuai SOP	Seluruh tenaga kesehatan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala ruangan diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Edukasi terkait keselamatan pasien akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.	Kepala ruangan	1 bulan

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi

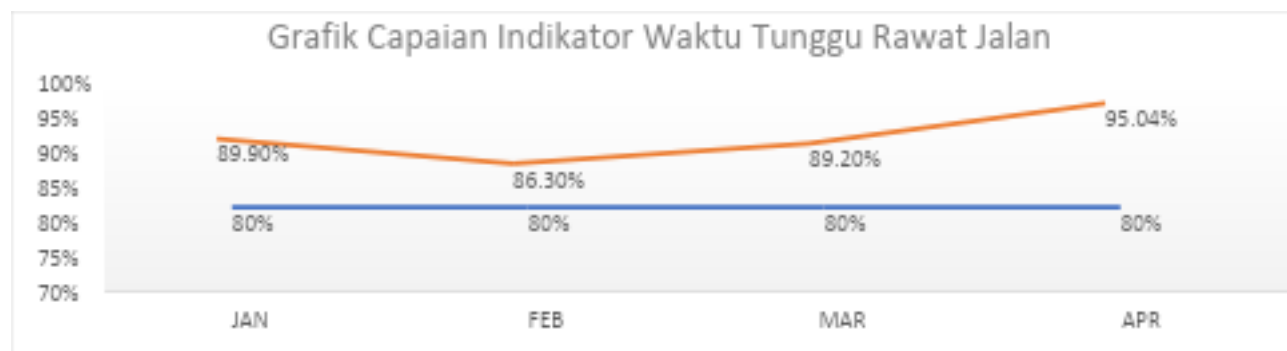


Gambar 3.4 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi

Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ≤ 30 menit mencapai 100%, sehingga telah melampaui standar minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Dari total 10 kasus operasi seksio sesarea emergensi, seluruh pasien mendapatkan pelayanan dengan waktu respons ≤ 30 menit. Keberhasilan capaian ini didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang optimal antara Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas, Instalasi Kamar Operasi, serta dukungan manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam menjaga mutu pelayanan kegawatdaruratan obstetri. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang yang optimal turut berperan dalam tercapainya indikator tersebut. Hasil yang telah dicapai perlu dipertahankan secara konsisten guna mengurangi risiko komplikasi pada ibu maupun bayi serta menjamin keselamatan pasien.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan

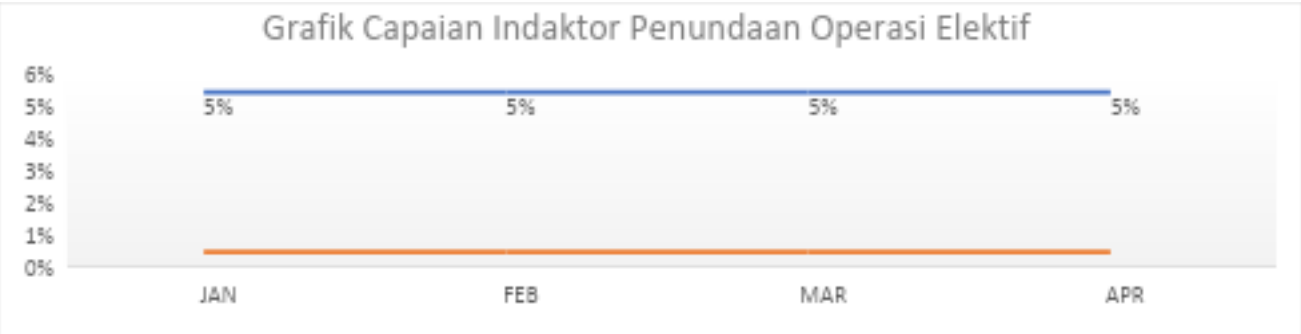


Gambar 3.5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan

Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator waktu tunggu pelayanan rawat jalan ≤ 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 95,04%. Hasil tersebut telah melampaui standar minimal yang ditetapkan yaitu $\geq 80\%$ serta mengalami peningkatan sebesar 5,84% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas alur pelayanan rawat jalan, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan awal, hingga pelayanan oleh dokter di poliklinik. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antar unit pelayanan, optimalisasi jadwal pelayanan, serta monitoring waktu tunggu secara berkala oleh manajemen dan unit terkait. Dengan capaian yang tinggi ini, diharapkan mutu pelayanan rawat jalan, kepuasan pasien, dan efisiensi pelayanan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

6. Penundaan Operasi Elektif

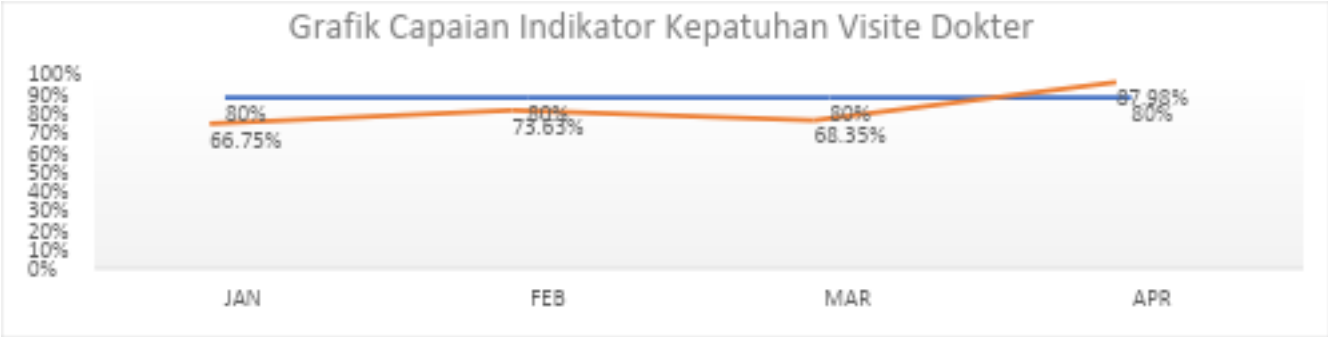


Gambar 3.6 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator penundaan operasi elektif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 0%, sehingga telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu $\leq 5\%$. Tidak adanya kejadian penundaan operasi elektif menunjukkan bahwa proses pelayanan operatif berjalan dengan baik dan terkoordinasi secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi yang baik antara Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar Operasi, serta dukungan manajemen rumah sakit dalam menjaga mutu pelayanan. Selain itu, perencanaan yang efektif terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan alat, dan pengaturan ruang operasi turut berkontribusi dalam mencegah terjadinya penundaan operasi elektif.

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter



Gambar 3.7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

Analisis:

Pada Bulan April 2026, capaian indikator kepatuhan waktu visite dokter di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 87,98%, mengalami peningkatan sebesar 19,63% dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil tersebut telah melampaui standar minimal yang ditetapkan yaitu $\geq 80\%$, sehingga menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan dokter dalam melaksanakan visite tepat waktu. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan secara berkesinambungan, antara lain penguatan komunikasi dan komitmen dengan DPJP terkait pelaksanaan visite sesuai jadwal yang telah disepakati, koordinasi aktif antara perawat dengan DPJP mengenai jadwal visite pasien, serta monitoring rutin oleh manajemen dan unit terkait terhadap pelaksanaan visite dokter. Unit yang telah mencapai kepatuhan waktu visite dokter sebesar 100% yakni IRNA 2A, IRNA 3A, dan IRNA 3C. Sementara itu, unit dengan capaian kepatuhan waktu visite dokter terendah adalah dari unit maternitas (52.98%). Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan mutu pelayanan pasien rawat inap, kontinuitas asuhan, serta kepuasan pasien dapat terus meningkat dan dipertahankan secara konsisten.

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

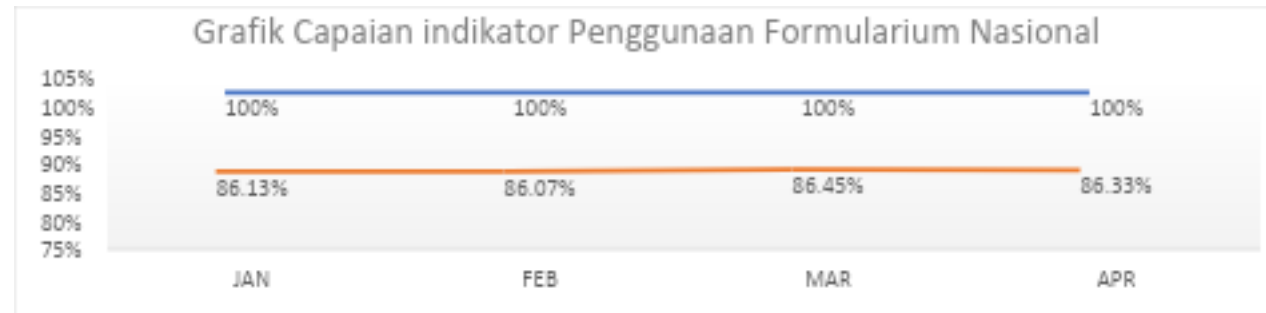


Gambar 3.8 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 100% dan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian tersebut juga berhasil dipertahankan selama empat bulan berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi petugas dalam melaksanakan pelaporan hasil kritis secara tepat dan sesuai prosedur. Keberhasilan ini mencerminkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar petugas laboratorium dengan unit pelayanan terkait dalam mendukung keselamatan pasien. Upaya yang terus dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut meliputi sosialisasi kebijakan dan SPO pelaporan hasil kritis, penguatan alur komunikasi hasil kritis antar unit, serta peningkatan kesadaran seluruh petugas untuk menjadikan pelaporan hasil kritis sebagai bagian dari budaya keselamatan pasien di rumah sakit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

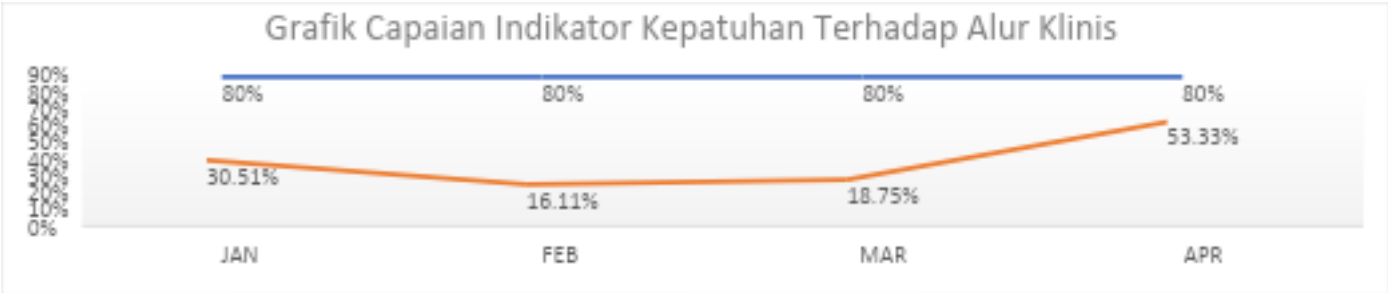


Gambar 3.9 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 86,33%. Capaian tersebut mengalami sedikit penurunan sebesar 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh masih berada di atas standar minimal yang ditetapkan yaitu $\geq 80\%$, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan hasil kritis laboratorium secara umum telah berjalan dengan baik. Penurunan capaian ini perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dalam proses pelaporan hasil kritis, baik dari aspek komunikasi, ketepatan waktu, maupun kepatuhan petugas terhadap prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan monitoring secara berkelanjutan agar capaian indikator dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan secara optimal sesuai standar yang telah ditetapkan.

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)



Gambar 3.10 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Analisis:

Pada Bulan April Tahun 2026, capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis (*clinical pathway*) RS Prima Husada Malang sebesar 53.33%. Hasil ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 44.63%. Namun, meski mengalami peningkatan, capaian ini masih jauh dari standar yang ditetapkan dengan gap sebesar 24.63%. Hal ini tentunya masih menjadi permasalahan untuk terus diupayakan perbaikannya agar semakin mengecilkan gap dengan standar setiap bulannya.

Tabel 3.6 PDSA Kepatuhan terhadap Alur Klinis

Problem	Capaian kepatuhan alur klinis pada Bulan April sebesar 53.33%, mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 34.58%. Namun, capaian ini masih jauh dari standar yang ditetapkan (80%). Beberapa faktor penyebab yang teridentifikasi antara lain kurangnya pemahaman petugas mengenai penggunaan alur klinis, keterbatasan waktu dalam pengisian dokumen, kurangnya monitoring dari unit terkait, dan masih belum dilakukan fiksasi untuk alur klinis yang disepakati oleh DPJP. Hal tersebut membuat tenaga medis belum sepenuhnya patuh mengisi dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>) pada pasien dengan diagnosis yang telah ditetapkan.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan terhadap alur klinis agar memenuhi standar yang ditetapkan (80%) dengan sosialisasi kembali mengenai penggunaan alur klinis, peningkatan monitoring kepatuhan pengisian oleh kepala ruangan atau PJ Mutu Unit, serta koordinasi dengan Komite Medik dan DPJP.
Do	Komite Mutu bersama Komite Medik melakukan sosialisasi dan edukasi kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pentingnya penggunaan alur klinis dalam pelayanan pasien. Selain itu dilakukan pengingat kepada DPJP dan petugas terkait untuk mengisi alur klinis sesuai diagnosis yang telah ditentukan. Kepala unit rawat inap juga diminta melakukan monitoring kelengkapan pengisian alur klinis pada rekam medis pasien.
Study	Capaian kepatuhan terhadap alur klinis pada bulan April sebesar 53.33%. Sementara pada bulan Maret mencapai 18.75% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 34.58%. Upaya yang dilakukan untuk menaikkan capaian tersebut adalah meningkatkan monitoring oleh kepala ruangan dan kabid pelayanan medis. Selanjutnya, upaya tersebut dapat terus ditingkatkan agar semakin mendorong tercapainya kepatuhan terhadap alur klinis untuk dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Action	1. Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>)

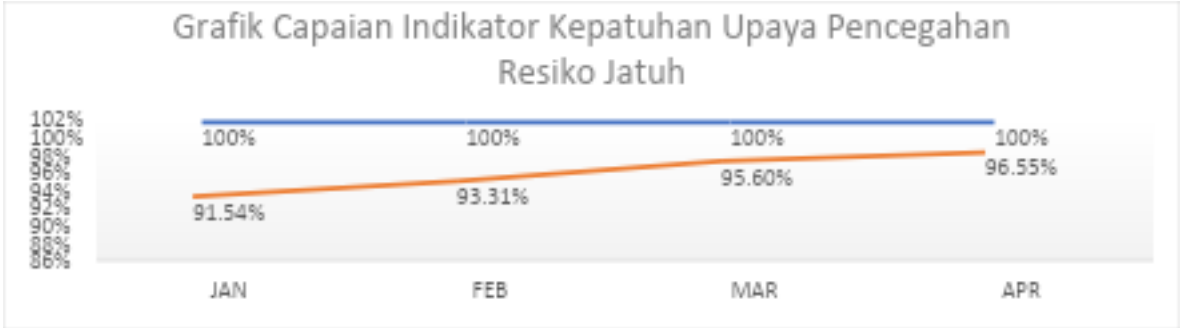
	2. Diskusi dengan PPA dalam fiksasi alur klinis yang dilakukan
--	--

Tabel 3.7 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (<i>clinical pathway</i>)	Meningkatkan kepatuhan pengisian dokumen alur klinis	Seluruh tenaga medis pelayanan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan alur klinis. Komite Medik bersama Komite Mutu akan melakukan penguatan implementasi clinical pathway kepada DPJP serta melakukan supervisi terhadap pengisian dokumen alur klinis dalam rekam medis pasien. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala serta pemberian umpan balik kepada unit pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis sehingga capaian indikator dapat mencapai standar yang ditetapkan.	• Komite Medik • Komite Mutu • Kabid Pelayanan Medis	1 bulan
2	Diskusi dengan PPA dalam fiksasi alur klinis yang dilakukan	Mendapatkan alur klinis yang telah disepakai oleh semua PPA sehingga PPA akan memberikan perawatan yang seragam.	Seluruh PPA	Rumah sakit akan melakukan penyamaan persepsi antar PPA mengenai alur pelayanan dan tahapan tindakan klinis sesuai SPO atau clinical pathway yang berlaku dan penguatan koordinasi dan komunikasi efektif antar PPA untuk memastikan kesinambungan pelayanan pasien	• Komite Medik • Komite Mutu • Kabid Pelayanan Medis • Komite Keperawatan • Kepala Instalasi Gizi	1-2 bulan

					Kepala Instalasi Farmasi	
--	--	--	--	--	--	--

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Gambar 3.11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Analisis:

Pada bulan April tahun 2026, capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 96.55%. Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 0.95%. Meskipun capaian ini mengalami peningkatan namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dengan gap sebesar 3.45%. Unit yang belum mencapai kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh sebesar 100% yaitu ICU, IKO, IRNA 4A, IRNA 5C, dan IRNA 8A. Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh paling rendah yaitu di IRNA 4A dengan capaian sebesar 63,42%. Perlu upaya perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.

Tabel 3.8 PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Problem	Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh pada Bulan April sebesar 96.55%. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun masih di bawah standar 100%. Terdapat gap sebesar 3.45% yang berisiko pada keselamatan pasien. Capaian belum mencapai standart 100% karena kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh belum optimal, edukasi pasien dan keluarga belum optimal, monitoring dan dokukemntasi belum lengkap.
Plan	Meningkatkan capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh agar memenuhi standar 100% dengan sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.
Do	- Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala - Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)

	- Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko - Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh
Study	Setelah dilakukan intervensi berupa edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh dan monitoring pemasangan pemberian tanda risiko jatuh didapatkan kenaikan capaian sebesar 0.95% dari bulan sebelumnya. Adanya peningkatan capaian menunjukkan bahwa upaya intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh. Upaya tersebut dapat terus dilakukan untuk semakin meningkatkan capaian sehingga mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Action	1. Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga/penunggu pasien untuk pencegahan jatuh 2. Monitoring pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)

Tabel 3.9 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga/penunggu pasien untuk pencegahan jatuh	Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai upaya pencegahan risiko jatuh selama perawatan	Pasien risiko jatuh dan keluarga/penunggu pasien	• Memberikan edukasi secara langsung saat pasien masuk rawat inap • Menggunakan media edukasi seperti leaflet/poster • Mengingatkan keluarga untuk mendampingi pasien risiko jatuh • Melakukan dokumentasi edukasi pada rekam medis	• Perawat ruangan • Kepala ruangan • Komite Mutu	Berkelanjutan
2	Monitoring pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)	Meningkatkan kedisiplinan staf dalam pencegahan risiko pasien jatuh	Perawat dan tenaga kesehatan	• Melakukan monitoring harian pemasangan gelang/label/stiker risiko jatuh • Melakukan audit kepatuhan secara berkala	• Perawat ruangan • Kepala ruangan • Komite Mutu	Berkelanjutan

				• Memberikan umpan balik kepada petugas apabila ditemukan ketidaksesuaian • Mengingatkan petugas melalui briefing/safety morning		
--	--	--	--	---	--	--

12. Kecepatan waktu tanggap komplain

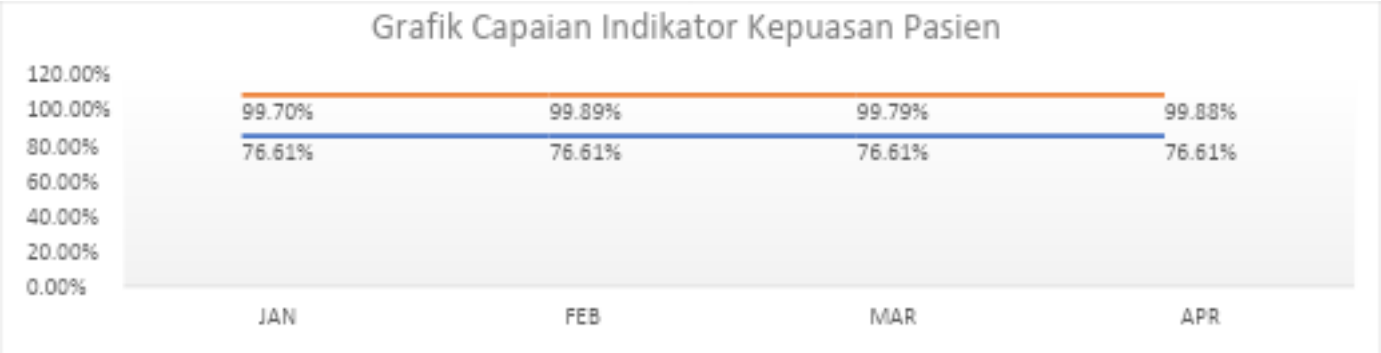


Gambar 3.12 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 100% dan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian ini juga berhasil dipertahankan selama empat bulan berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi rumah sakit dalam memberikan respons cepat terhadap setiap komplain yang diterima. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik antara PIPP dengan manajemen rumah sakit dalam melakukan tindak lanjut komplain secara cepat dan tepat. Selain itu, tersedianya mekanisme pelaporan komplain yang mudah diakses melalui PIPP, telepon, WhatsApp, maupun formulir online turut meningkatkan efektivitas penerimaan dan penanganan komplain pasien. Dukungan sumber daya manusia yang telah terlatih dalam manajemen komplain serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi faktor penting dalam tercapainya indikator ini. Capaian tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien

Analisis:

Pada bulan April 2026, capaian indikator kepuasan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 99,88%, mengalami peningkatan sebesar 0,09% dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil tersebut telah melampaui standar yang ditetapkan yaitu $\geq 76,61\%$, sehingga menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit telah mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pasien dengan sangat baik. Peningkatan capaian ini mencerminkan adanya upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh unit pelayanan, baik dari aspek komunikasi petugas, kecepatan pelayanan, kenyamanan fasilitas, maupun ketepatan pemberian asuhan kepada pasien. Capaian yang tinggi ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui evaluasi rutin, tindak lanjut terhadap masukan pasien, serta peningkatan budaya pelayanan prima guna menjaga kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit.

3.2 Pemantauan Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

Tabel 3.10 Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan

	pasien rawat jalan (farmasi)															
2.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap	92.42%	92.14%	92.90%	92.83%									100%	92.52 %	PDSA
4.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
5.	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	85.05%	85.70%	85.91%	86.59%									100%	85.55 %	PDSA
6.	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	-	87.11%	92.08%	98.42%									100%	89.60 %	PDSA

3.3 Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

Tabel 3.11 Capaian Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No.	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	-	7.08%	12.50%	11.9%									100%	11.90%	PDSA
2.	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	-	12.1%	21.48%	12.34%									100%	12.34%	PDSA
3.	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)	-	8.31%	12.05%	17.94%									100%	17.94%	PDSA

3.4 Tujuan Strategis

Tabel 3.12 Capaian Indikator Mutu Tujuan Strategis

NO	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26			
1.	Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i>	5	1	3	11									0	5	PDSA

3.5 Perbaikan Sistem

Tabel 3.13 Capaian Indikator Mutu Perbaikan Sistem

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26			
1.	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	89.62%	82.66%	83.15%	86.44%									100%	85.47%	PDSA

[illegible]

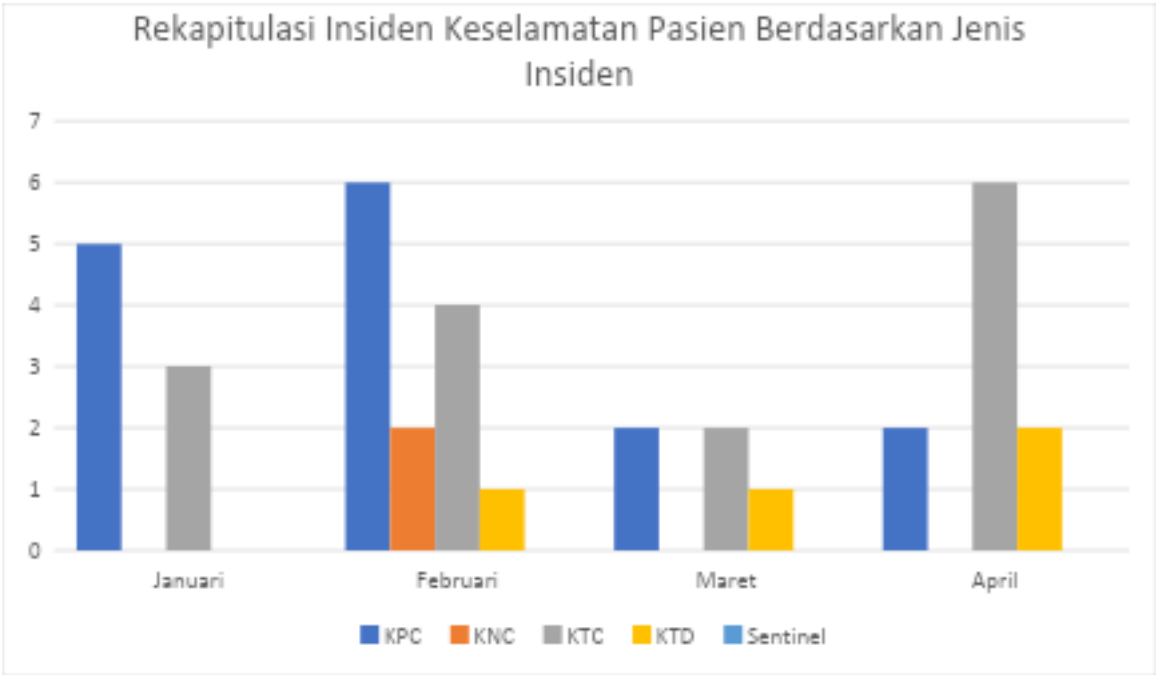
[illegible]

BAB III
INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

3.1 Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden

Tabel 3.1 Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden

	KPC	KNC	KTC	KTD	SENTINEL	JUMLAH
JANUARI	5		3			8
FEBRUARI	6	2	4	1		13
MARET	2		2	1		5
APRIL	1		7	2		10
MEI						
JUNI						
JULI						
AGUSTUS						
SEPTEMBER						
OKTOBER						
NOVEMBER						
DESEMBER						
JUMLAH	15	2	15	5		37



Gambar 3.1 Grafik Rekapitulasi Insiden Keselamatan Pasien Berdasarkan Jenis Insiden

3.2 Laporan IKP Bulan April

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
1	06 April	Deya	Maternitas	KTC	Bidan salah menginput data di kematian maternal yang seharusnya di kematian abortus di web MPDN, sehingga data yang diisi sesuai dengan KTP Ibu.	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaporkan ke Kemenkes RI sehingga data kematian maternal sudah dihapus. 2. Dilakukan input kematian abortus. 3. Penyampaian kesalahan input di aplikasi kepada pasien dan suami pasien oleh MOD.
2	11 April	Hefti, Lilis, Defi	Farmasi	KTC	Kesalahan penulisan etiket obat antara antibiotik dan obat anti nyeri sehingga pasien tidak menghabiskan antibiotik yang seharusnya dihabiskan	1. Melakukan pengecekan ulang etiket setelah di print. 2. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). 3. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
3	12 April	Nisa	IRNA 2C	KTC	Kesalahan pemberian obat injeksi. Perawat memberikan obat kepada pasien anak dengan cara dibolus, seharusnya obat pekat diberikan secara didrip, sehingga anak menangis. Lalu keluarga komplain karena infus tiba-tiba menetes cepat.	1. (a) Pendokumentasian perintah DPJP dalam pemberian obat terutama untuk jenis injeksi kepada pasien anak-anak. (b) Jika cara pemberian obat belum jelas dan perawat ragu-ragu atau bingung, boleh bertanya ke DPJP. (c) Refreshing 5B pemberian obat. (d) Memberikan informasi yang detail dan jelas termasuk pemberian obat saat operan shift. 2. Perawat senior harus mendampingi perawat baru setiap melakukan tindakan ke pasien. 3. (a) KIE kepada keluarga pasien terutama pasien anak, jika infus menetes cepat, bisa memberitahu perawat. (b) Menggunakan prosedur yang benar saat membenahi tetesan infus. 4. Masukan dari dr. Heru, jika terjadi komplain, boleh meminta DPJP untuk menjelaskan ke keluarga pasien, agar lebih membuat tenang.

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
						5. Koordinasi dengan komite keperawatan
4	14 April	Karisa	IGD	KPC	Kesalahan penulisan form SBAR karena perawat copy paste advice DPJP di WA tanpa melakukan pengecekan ulang identitas pasien sehingga form SBAR yang tertulis di e-RM adalah milik pasien lain.	1. Melakukan <i>crosscheck</i> sebanyak 3x saat menuliskan SBAR di E-RM 2. Harus melihat identitas sebelum menulis SBAR di E-RM
5	16 April	Lilis, Wisnu	Farmasi	KTC	Kejadian kesalahan pemberian antibiotik karena staf farmasi kurang teliti menyiapkan obat. Perawat IRNA hanya double check di etiket tapi tidak di obatnya sehingga tidak menyadari obat yang diberikan farmasi berbeda dengan obat yang diadvicekan DPJP	1. Melakukan pengecekan ulang/verifikasi obat sesuai SPO Verifikasi Pemberian Obat Rawat Inap dan pelaksanaan 5 benar telaah obat (Benar Pasien, Benar Obat, Benar Dosis, Benar Rute, Benar Waktu Pemberian)
6	21 April		IKO, ICU	KTD	Kejadian penurunan kesadaran dan gangguan napas pasca operasi remove implant diduga dipicu krisis hipertiroid yang sebelumnya tidak teridentifikasi saat pengkajian praoperasi karena pasien memiliki riwayat hipertiroid namun tidak rutin	1. Melakukan penguatan pengkajian praoperasi sesuai SPO asesmen pra anestesi dan pra operasi melalui verifikasi ulang riwayat penyakit pasien, riwayat pengobatan, serta pemeriksaan penunjang yang

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
					berobat, sehingga pasien memerlukan perawatan intensif di ICU.	diperlukan, disertai peningkatan komunikasi dan koordinasi antar DPJP, dokter anestesi, perawat, dan pasien/keluarga guna meminimalkan risiko komplikasi perioperatif.
7	22 April	Mita, Ara, Wahyu	Maternitas	KTD	Bidan memberikan premed ondansentron padahal DPJP tidak memberi advice tersebut. Kemudian muncul bentol-bentol di tangan pasien akibat reaksi alergi ondansentron sehingga pelaksanaan kuret ditunda	1. Pengkajian alergi harus terkaji mulai awal, jika di awal belum terkaji, harus dikaji pada tahap selanjutnya. 2. Memberikan pertanyaan terbuka jika bertanya ke bidan lain mengenai premed yang diberikan. Bidan juga harus meningkatkan fokus dan tidak memberikan tanggapan dengan mengangguk saja. 3. Melihat kembali advice DPJP di WA sebelum memberikan asuhan pada pasien.
8	23 April	Amalya	Farmasi	KTC	Kesalahan penyiapan obat karena petugas tidak teliti konversi dosis sesuai obat yang tersedia sehingga jumlah obat kurang	1.Melakukan pengkajian resep dan konversi dosis sesuai resep. 2.Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). 3.Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas

No.	TGL KEJADIAN	STAF YG TERLIBAT		Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
		NAMA	UNIT			
						yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
9	24 April	dr. Yoga, Ana, Sina, Sherli, Aris, Susanti, Resta	Farmasi	KTC	Kesalahan penyiapan obat diawali dari DPJP tidak teliti dalam menginput resep, kemudian sudah direvisi namun petugas tidak teliti menyiapkan obat yang seharusnya diberikan sebanyak 60 tablet, hanya diberikan sebanyak 30 tablet. Lalu apoteker melakukan identifikasi pasien dan melakukan double check etiket dan obat dengan resep namun tidak teliti melihat kesesuaian resep dan jumlah obat.	1. Koordinasi dengan komite medik 2. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). 3. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
10	29 April	Roida	IGD	KTC	Kesalahan penulisan SBAR karena perawat langsung mengcopy paste advice DPJP tanpa melihat identitas pasien.	1. Melakukan <i>crosscheck</i> sebanyak 3x saat menuliskan SBAR di E-RM 2. Harus melihat identitas sebelum menulis SBAR di E-RM

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Komite Mutu rumah sakit di Rumah Sakit Prima Husada Malang Bulan April Tahun 2026. Upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal yang bisa dikerjakan saat ini, tentunya upaya yang berkesinambungan dan tidak mengenal lelah terus dilakukan sehingga tercapai hasil tertinggi bagi semua komponen pemberi dan pengguna layanan rumah sakit.

Malang, 09 Mei 2026

Ketua Komite MUTU



dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M

Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

